游戏结合言语训练在2~5岁语言发育迟缓高危儿童康复护理中的作用评价

赵小燕，李娟，陈莲，余海霞，代梦琴

绵阳市中心医院（电子科技大学医学院附属绵阳医院）儿科，四川　绵阳　621000

摘　要：目的　评价游戏结合言语训练在2~5岁语言发育迟缓高危儿童康复护理中的作用。**方法**　选取2022年1月—2024年1月本院收治的78例2~5岁语言发育迟缓高危儿童，分别采用常规康复护理（对照组）和游戏结合言语训练（研究组），记录并比较患儿的临床指标。**结果**　研究组经护理后的语言能力评分、神经心理发育水平、生活质量评分以及患儿家属护理满意度均更高（$P<0.05$）。**结论**　在2~5岁语言发育迟缓高危儿童康复护理中，为了进一步促进患儿身心健康的优化，护士应在常规康复护理的基础上积极做好游戏结合言语训练的引入与应用。

关键词：游戏结合言语训练；2~5岁语言发育迟缓高危儿童；康复护理；语言能力

DOI:10.19335/j.cnki.2096–1219.2025.18.047

Evaluation of the Role of Game Combined with Speech Training in Rehabilitation Nursing of High-Risk Children with Language Retardation Aged 2~5 Years

ZHAO Xiaoyan, LI Juan, CHEN Lian, YU Haixia, DAI Mengqin

Department of Pediatrics, Mianyang Central Hospital (Affiliated to the School of Medicine, University of Electronic Science and Technology of China), Mianyang, Sichuan 621000

ABSTRACT: **Objective** To evaluate the role of games combined with speech training in rehabilitation nursing of high-risk children with language retardation aged 2~5 years. **Methods** From January 2022 to January 2024, 78 high-risk children aged 2~5 with language retardation were selected and treated with routine rehabilitation nursing (control group) and game combined with speech training (research group), respectively, and the clinical indexes of the children were recorded and compared. **Results** The language ability score, neuropsychological development level, quality of life score and nursing satisfaction of parents of children in the study group were higher after nursing ($P<0.05$). **Conclusion** In the rehabilitation nursing of high-risk children with language retardation aged 2~5 years, in order to further promote the optimization of children's physical and mental health, nurses should actively introduce and apply games combined with speech training on the basis of routine rehabilitation nursing.

KEYWORDS: Game combined with speech training; High-risk children with language retardation aged 2~5 years; Rehabilitation nursing; Linguistic competence

0　引言

在儿童成长过程中，语言发育迟缓是一种比较常见的问题，其多发生在2~5岁这一年龄段，对儿童的身心健康和日常生活造成了一定的影响与限制。部分调查结果显示，导致语言发育迟缓的因素相对较为复杂，其中构音器官疾病与儿童所处的语言环境不良是较为常见的影响因素。在儿童成长期间，相关问题可导致患儿的认知能力、读写能力以及行为能力受到影响，继而导致患儿承受相应的身心压力与负担[1]。基

基金项目：本文系绵阳市社会科学研究重点基地《四川绵阳未成年人心理成长指导与研究中心》资助（项目编号：SCWCN2020Y1315）

作者简介：赵小燕（1978—），女，汉族，四川绵阳人，本科，副主任护师，研究方向：儿童青少年心理治疗、护理管理。

中国知网　https://www.cnki.net

于此，为了进一步促进语言发育迟缓高危儿童健康的改善，护理学者基于实践，对此类患儿的共性特征进行了分析，梳理了相应的康复护理方案，希望进一步促进相关护理工作的多元化发展。调查资料显示，通过积极利用游戏语言与训练进行结合干预，护士可以在护理工作开展期间进一步做好与患儿之间的沟通交流。与此同时，这一系列护理指导方法更加契合2~5岁儿童对于新鲜事物的好奇心和身心诉求，这一点对于护理工作开展期间患儿群体体验感的优化和护理配合度的提升具有重要的促进作用，推动了整体护理服务工作水平的提升和持续拓展[2]。本文针对游戏结合言语训练在2~5岁语言发育迟缓高危儿童康复护理中的作用进行了评价，现整理汇报如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2022年1月—2024年1月本院收治的78例2~5岁语言发育迟缓高危儿童，并分为对照组和研究组，每组39例。对照组：男23例，女16例；年龄为2~5岁，平均（3.78±0.25）岁。研究组：男22例，女17例；年龄为2~5岁，平均（3.81±0.34）岁。患儿的监护人均对本次研究内容知情同意，且相关内容已经上报伦理委员会并顺利通过审批。两组患儿一般资料差异无统计学意义（$P>0.05$）。

1.2 方法

对照组：采用常规康复护理。①观察患儿康复期间的生命体征情况并进行记录，完善患儿档案。②结合医生开具的处方，为患儿发放治疗药物并告知患儿家属这些药物的使用方法和用量，确保患儿严格遵医嘱用药。③做好康复期间注意事项的及时宣教与说明。④做好患儿病房的定期巡视。

研究组：在对照组的基础上采用游戏结合言语训练。①游戏指导：护士应在门诊康复护理期间握住患儿手掌并引导其根据节奏进行拍手。在此期间，应鼓励患儿说出“拍拍手”等简单的词汇和句子，还可以引导患儿聆听相应的儿歌并鼓励其进行儿歌的说唱练习，这一点可以帮助患儿有效实现对语言能力的培养。同时，护士还应鼓励患儿家属利用相应的图片和照片鼓励患儿对相关事物进行观察和分析，并说出照片中的物体。在门诊护理期间，护士应积极做好与患儿之间的沟通与交流，鼓励患儿根据自己喜欢玩的玩具、喜欢吃的水果以及感兴趣的话题进行语言表达，这一点对于患儿语言发育水平的优化具有重要的促进意义。此外，护士还应在门诊护理过程中利用沙盘室鼓励患儿开展游戏，引导患儿在沙滩上摆出自己喜欢的一些作品并进行介绍和说明，这一点可以帮助患儿在游戏的同时实现语言表达能力的提升。沙盘游戏的频次为40 min/次，1次/周。②言语训练：在训练过程中，护士应遵循循序渐进的训练原则，以简单地模仿他人说话作为起始点引导患儿，积极做好对于单字和简单词的复述，随后鼓励患儿进行短语和句子的练习。在练习过程中，应积极鼓励患儿用语言表达自己的诉求。护士应耐心对患儿进行引导并积极肯定患儿做出的一些努力，还应对患儿的口周进行按摩，帮助患儿对于嘴唇灵活度进行合理练习，这一点对于患儿语言能力的提升具有积极意义。可以通过咂嘴、噘嘴、龇牙、舔嘴唇等相关功能训练帮助患儿进行练习。在训练过程中，护士应逐渐增加患儿的词汇量，从而引导其积极做好对于语言的合理应用和充分表达，及时以生活中的一些常见话题作为切入点与患儿进行沟通，从而促进其语言能力的提升。

1.3 观察标准

（1）比较患儿语言能力评分，通过儿童语言迟缓评价法（S-S）对儿童语言迟缓情况进行评估，评估内容包括符号形式、记忆与模仿、操作性课题、交流态度及指示内容等，将评估结果与同龄人进行对比，若低于实际年龄则代表相应评估项目存在异常。

（2）比较患儿神经心理发育水平，通过Gesell发育量表评估患儿发育情况，总计5个能区，分别为个人社交行为、语言、适应行为、精细动作及大动作，分别对各个能区发育商（DQ）进行计算，以总分不低于86分代表正常，得分越低则代表发育越差。

（3）比较患儿生活质量改善情况，通过儿童少年生活质量量表（QLSCA）进行评估，涵盖领域包括生理、心理、生活环境与社会功能，总计13个维度，总分为100分，得分越高则代表患儿生活质量越好。

（4）通过分发护理满意度调查问卷的方式统计和调查患儿家属的护理满意度，包括护理人员护理态度、人文关怀、护理技能、护患沟通、健康宣教等，总分值为100分，包括满意（≥90分）、基本满意（60～89分）和不满意（<60分），基本满意与满意例数占总例数比例×100%为总满意度。

1.4 统计学方法

采用SPSS 26.0软件进行统计分析，计量资料采

中国知网 https://www.cnki.net

用t检验，以（$\bar{x} \pm s$）表示；计数资料采用χ^2检验，以[n（%）]表示。以$P<0.05$为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患儿语言能力评分对比

护理前，两组患儿语言能力评分对比，差异无统计学意义（$P>0.05$）；护理后，研究组患儿的语言能力评分更高（$P<0.05$）。见表1。

2.2 两组患儿神经心理发育水平对比

护理前，两组患儿神经心理发育水平对比，差异无统计学意义（$P>0.05$）；护理后，研究组患儿的神经心理发育水平更高（$P<0.05$）。见表2。

2.3 两组患儿生活质量对比

护理前，两组患儿生活质量对比，差异无统计学意义（$P>0.05$）；护理后，研究组患儿的生活质量评分更高（$P<0.05$）。见表3。

2.4 两组患儿家属护理满意度对比

研究组患儿家属护理满意度更高（$P<0.05$）。见表4。

3 讨论

从护理工作的角度分析，对于2~5岁语言发育迟缓高危儿童而言，良好的护理引导有利于促进其语言发育水平的提升与优化，为患儿身心健康的改善奠定了坚实的基础与保障。对于幼儿群体而言，在其生长发育期间，语言发育迟缓较为常见，这一点与幼儿日常生活中缺乏相应的语言使用环境和相关疾病具有一定关联[3]。为了有效推动患儿身心健康的持续优化，护理学者从门诊护理的视角出发，对2~5岁语言发育迟缓高危儿童群体的康复护理方法进行了梳理，推动了大量护理经验的总结和应用，对于护理干预手段的持续优化具有重要的促进意义[4]。实践表明，在

表1 两组患儿语言能力评分对比（$\bar{x} \pm s$，分）

组别	n	护理前	护理后
研究组	39	48.22 ± 3.20	77.12 ± 2.68
对照组	39	48.29 ± 3.14	69.95 ± 2.78
t	—	0.098	11.596
P	—	0.923	0.000

表2 两组患儿神经心理发育水平对比（$\bar{x} \pm s$，分）

组别	n	语言		社交行为	
		护理前	护理后	护理前	护理后
研究组	39	41.17 ± 2.11	76.32 ± 2.24	42.08 ± 3.12	72.85 ± 2.61
对照组	39	41.21 ± 2.08	70.69 ± 2.30	42.36 ± 3.12	66.64 ± 2.78
t	—	0.084	10.951	0.396	10.170
P	—	0.933	0.000	0.693	0.000

组别	适应能力		精细动作		大动作	
	护理前	护理后	护理前	护理后	护理前	护理后
研究组	51.03 ± 2.14	73.62 ± 2.45	56.47 ± 2.64	82.46 ± 2.12	54.29 ± 2.27	81.30 ± 2.46
对照组	51.21 ± 2.16	65.69 ± 2.46	56.63 ± 2.75	77.31 ± 2.27	54.74 ± 2.15	73.07 ± 2.28
t	0.370	14.264	0.262	10.355	0.899	15.323
P	0.713	0.000	0.794	0.000	0.372	0.000

表3 两组患儿生活质量对比（$\bar{x} \pm s$，分）

组别	n	护理前	护理后
研究组	39	75.32 ± 2.74	92.91 ± 2.58
对照组	39	75.65 ± 2.46	85.15 ± 2.17
t	—	0.560	14.375
P	—	0.577	0.000

表4 两组患儿家属护理满意度对比[n（%）]

组别	n	满意	基本满意	不满意	总满意度
研究组	39	25	12	2	94.87
对照组	39	15	16	8	79.49
χ^2	—	—	—	—	4.129
P	—	—	—	—	0.042

中国知网 https://www.cnki.net

门诊护理工作开展期间，通过积极利用游戏作为载体组织患儿进行康复护理工作，护士可以在游戏过程中帮助儿童进一步实现对于相关话题的充分认识，并调动其表达的积极性和热情，这一点对于患儿表达能力的持续提升具有良好的辅助作用[5]。在康复护理工作开展期间，这一模式更加契合于儿童对于新鲜事物的探究心理和意识，有助于提升儿童的整体康复护理体验感，并优化其在康复护理活动中的参与积极性和主观能动性[6-7]。在此基础上，通过利用言语训练进行配合，护士可以积极结合相关话题和患儿进行更为系统的沟通与交流。实践表明，相关工作的持续推进可以帮助患儿有效围绕相关话题尝试表达自己的一些想法，对于其语言发育水平的提升具有重要的促进意义[8-9]。在康复护理工作开展期间，通过积极遵循循序渐进的训练原则与患儿进行沟通交流，并积极向患儿家属讲授康复训练方法，护士可以及时发挥自己的护理价值，其对于患儿语言功能的持续优化和自我意识表达能力的提升具有重要的促进意义[10-11]。基于此，患儿可以更好地在日常生活中与家属就相关话题进行交流与互动，其对于患儿语言发育目标的达成和身心健康的持续优化具有重要的促进意义，推动了患儿整体健康的改善[12-13]。从全局观的视角来看，相关工作的持续推进可以帮助患儿更好地学会与人沟通与交流，并促进其良好社会关系的充分构建，这一点为患儿身心的全面成长奠定了坚实的基础。

本次研究结果显示，通过游戏结合言语训练的实施，护士可以帮助患儿有效实现对于语言能力的训练，其对于患儿语言能力评分和神经心理发育水平的优化具有良好的促进作用。基于此，患儿可以更好地表达自己的内心想法，其对于患儿生活质量的提升与患儿家属护理满意度水平的优化具有良好的促进作用。

综上所述，为了促进2~5岁语言发育迟缓高危儿童康复护理服务质量的提升，护士应在护理期间积极做好游戏结合言语训练的组织。

参考文献

[1] 郑菁娟.早期康复护理在语言发育迟缓儿童中的应用效果探讨[J]. 智慧健康,2023,9(12):269–272.

[2] 吴素华,毕圣洁.游戏结合言语训练在2~5岁语言发育迟缓患儿康复护理中的应用[J].中外医学研究,2022,20(8):104–107.

[3] 刘翠娟.沙盘游戏结合言语训练在语言发育迟缓患儿康复护理中的应用效果观察[J].反射疗法与康复医学,2022,3(7):167–170.

[4] 庞慧.游戏结合言语训练在2～5岁语言发育迟缓高危儿童康复护理中的应用效果[J].中西医结合护理（中英文）,2021,7(10):82–84.

[5] 刘丹,许诗浩,黄月.引导式教育联合早期康复护理干预对语言发育迟缓儿童发育商的影响[J].罕少疾病杂志,2024,31(1):128–129,136.

[6] 李妮.游戏结合言语训练在2~5岁语言发育迟缓儿童康复护理中的应用效果[J].实用医学研究,2022,4(1):117–118.

[7] 宋晓梅.早期康复护理干预在语言发育迟缓儿童中的应用效果观察[J]. 中外医药研究,2023,2(9):100–102.

[8] 周灵芝,刘倩,梁伟健.游戏辅以言语训练在语言发育迟缓患儿康复护理的效果评价[J].护士进修杂志,2021,36(18):1720–1722.

[9] 饶治琴,陈秀锦,王琪.家庭康复护理联合融合趣味游戏的语言康复训练对语言发育迟缓患儿的康复效果[J].保健医学研究与实践,2023,20(z2):212–214.

[10] 靳大丽.重复经颅磁刺激联合综合康复训练对语言发育迟缓患儿发育商、语言发育商的影响[J].反射疗法与康复医学,2021,2(12):134–136,140.

[11] 饶治琴,陈秀锦,王琪. 家庭康复护理联合融合趣味游戏的语言康复训练对语言发育迟缓患儿的康复效果[J].保健医学研究与实践,2023,20(z2):212–214.

[12] 王敏囡,祖姆热提·伊敏,帕如克·亚勒昆,等.家庭互动式阅读对1~6岁语言发育迟缓患儿语言康复的作用[J].中国听力语言康复科学杂志,2023,21(1):69–71.

[13] 兰海,周欣,彭丹,等.互动式阅读家庭训练联合早期认知语言康复训练对儿童语言发育迟缓的疗效及对Gesell评分的影响[J].智慧健康,2024,10(24):158–160,164.

中国知网 https://www.cnki.net